

침구의학 SUMMARY 공지사항

- 출석을 원하실 때 부르신다고 합니다. 출퇴 및 자리비움은 조심하시는게 좋겠습니다.

침구의학 SUMMARY 사용법

- 추가 설명 및 예시: 회색

- 강조: **빨간색**, 밑줄

[1] 의학면담 The medical interview

! 의학면담이란?

방문문절을 통해 환자의 상태를 파악하는 과정

1절. 의학면담의 세 가지 목적

- 1) 효과적인 의사-환자 관계를 확립하고 유지하기 위함 (=라포 형성)
- 2) 환자의 문제를 진단하기 위함
- 3) 환자가 치료 방침에 잘 따르도록 교육하고 격려하기 위함

2절. 질병에 대한 정상반응

1. 질병의 일반적인 스트레스 여기서 질병은 심각한 질환 혹은 만성질환을 의미

- 1) 효율성에 대한 위협 ex) 청소마저하기 어려운 상황
- 2) 분리 위협 ex) 가족과 떨어져 지냄
- 3) 애정 상실의 위협 ex) 질환으로 인한 매력저하에 의해
- 4) 신체기능 상실의 위협 ex) 요실금
- 5) 신체부위 상실의 위협 ex) 다리 절단
- 6) 합리성 상실의 위협
- 7) 통증의 위협

2. 질병의 적응 과제

- 1) 정서적 균형의 유지 / 2) 사회적 관계의 유지 / 3) 가족관계의 유지
- 4) 기능장애에 대처하기 / 5) 알려지지 않은 것에 대처하기
- 6) 통증에 대처하기 / 7) 다양한 의료인들에 대한 적응

3. 질병에 대한 '정상적' 정서 반응

- 1) 퇴행: 정서적 기능이 유아적 단계로 바뀌는 것. 질병기간 동안 신체·정신적 의존성을 높임
- 2) 부정, 의식적 억압, 무의식적 억압
 - suppression(억제): 질병에 관한 생각을 마음속에서 지우거나 피하려고 하는 것
 - repression(억압): 의식에서 무의식으로의 생각의 이동
 - 부정하고 오진일 것이라 생각하면 의사로부터의 정보를 무시함
 - ⇒ 방어기전 중 가장 좋지 않음
- 3) 불안: 빈맥, 위장관 운동항진, 발한, 불면 등 자율신경계 흥분 등의 신체적 증상으로 나타나 질병에 영향을 줄 수 있음
- 4) 분노 · 5) 슬픔 ✓ 슬픔과 우울증은 구별해야 함

3절. 부적응 반응

! 부적응 반응이란?

질병에 대한 정서반응이 지나쳐 환자들의 기능에 장애를 주는 반응

1. 지속적인 분노

- 의사에 대한 부적절한 분노는 질병에 대한 분노가 대치된 것임
- 관심을 끌기 위한 분노요구와 더욱 심한 소외, 고립이 나타날 수 있음

2. 우울 감정이 동반된 적응 장애와 주요 우울증

- 슬픔이 나타나는 것은 정상. But 슬픔, 절망이 지속되고 심각할 때 발생
 - +단순한 슬픔이 아닌 우울증은 정신과적 치료도 동반되어야 함
- 주요 우울증: 적어도 2주간의 지속적인 불행감과 무감동을 포함한 증상과 증후군들
- 특징적인 신체 징후(불면, 식욕부진, 정신운동 지체 등), 정신적 증상(집중력 감소), 낮은 자존심(자존감), 죄책감, 절망감)

3. 불안감을 동반한 적응장애/불안장애

- 환자를 무기력하게 만들고 신체적 회복 과정을 방해하며, 주치의와 주변을 괴롭힘
- 자율신경계 항진이 나타날 수 있음
- 지속적 불안은 불안감을 동반한 적응장애, 공황장애, 범불안 장애로 진단되기도 함
- 우울증과의 차이: 우울보다 억압, 두려움, 신경증이 더 분명함

4. 부적응 감정반응을 가진 환자에 대한 면담전략

- 경청하고 반영, 정당화 등의 방법을 사용하면 좋음
- 그러나 감정적 반응이 지속적 형태로 고정된다면 정신과 의뢰, 약물이 필요

4절. 의학면담의 세 가지 기능

1. 첫 번째 기능: 관계 형성

- 환자/가족의 감정반응에 의사가 대응하는 방법이 전반적인 의사-환자 관계를 결정
- 효과적인 동반자 관계 → 치료/면담과정의 기초가 됨
- 즉 진료의 감정적 영역이 치료 결과 결정에 중요한 역할을 함
 - ∴ 의사는 환자와의 대화에서 정신적, 감정적, 관계적 측면을 이해해야 함
- 의사-환자 관계는 진료의 기초가 됨
- 관계 형성: 의사의 가장 중요한 대화 기법인 감정 대응 기법들을 사용하는 것
- 환자는 의사가 지식이 풍부하고 기술적으로 유능하길 바라며, 또한 확신을 주고, 지지적이며, 정서적으로 도와주기를 바람

→라포형성. 잘 될수록 치료효과 및 순응도가 높으며, 문제 및 부작용도 가볍게 해결 가능

- 관계 형성 기법 : ①비언어적 기술 ②공감 ③개인적지지 ④동반자 의식 ⑤존중

▶ 관계 형성 기법

① 비언어적 기술 < '말' 이외의 것들

- 적절한 신체 자세, 움직임, 얼굴 표정, 목소리 크기, 말하는 속도, 접촉 등

- 의사의 언어적, 비언어적 행동 사이에 일관성이 있어야 함
 - 언어-비언어 일치하지 않으면 보통 비언어적 표현이 더 전달됨
 - ex. "어디가 아프세요?"(언어) 라고 말하는데 행동은 관심이 없는(비언어) 경우, 듣는 입장에선 상대방이 관심 없다고 판단
- 환자와 적절히 눈을 맞춘다.
- 공간을 잘 이용한다.
 - 의사-환자 사이의 수직 공간은 최소로 줄이고(너무 차이나지 않게), 수평공간은 주의해서 유지 (너무 가깝거나/멀거나 하지 않게)
- 환자의 비언어적 행동을 보면 감정반응을 알 수 있음

② 공감 (empathy)

- 다른 사람의 감정상태를 받아들이고 그 사람을 인정하고 이해하는 것
- 비언어적 행동은 구체적인 언급(언어적 표현)보다 때때로 더욱 효과적
 - ex. 단순히 시선을 맞추고 지긋이 바라보기 등으로 공감을 표현

(1) 반영 (reflection)

- 환자가 보이는 감정이나 느낌을 의사가 표현하는 것 ex. 많이 놀라셨죠?
- 감정을 다루는 것이 면담 시간을 증가시킨다고 생각하나, 연구결과 시간을 증가시키지 않으면서 만족감, 정보공개 등의 결과를 호전시킴
- 위협적이지 않고 쉽게 받아들일 수 있는 용어로 표현
 - ex. "매우 화나 보이시군요."(x) "속상한 일이 많으시죠."(o)
- 환자가 자신의 감정에 대해 대화하기를 원하지 않으면 이를 존중

(2) 정당화 (legitimation)

- 반영과 유사하나, 환자가 경험하는 감정을 인정하고 존중한다는 사실을 말해주는 것
- 화를 내는 논리에 의사가 동조할 필요는 없지만, 중요한 것은 환자의 입장에서 분노를 이해하려고 노력하는 것(감정에 동조)

ex) 컴플레인 환자를 만났을 때, 잘못을 따지기보단 기분에 공감해주어 화 풀어주기.
이후 이성적인 상태에서 대화하는 것이 좋음

③ 개인적 지지

- 환자에게 의사가 그들의 편에서 개인적으로 도와주기를 원한다는 사실을 알려주도록 노력. 물론 솔직하지 않으면 효과X: ex. "가능하면 도와드리고 싶습니다."

④ 동반자 의식

- 환자는 의사와 동료의식을 느꼈을 때 더 만족하고 의사의 처방을 더 잘 따르게 됨

⑤ 존중

- 환자에 대한 존중은 경청, 비언어적 표시, 시선집중, 관심집중으로 표현됨
- 여기서는 환자의 한 가지 행동에 대한 칭찬을 말함
ex. 스트레칭하라고 교육시켰는데 했으면 너무 잘했다고 칭찬

2. 두 번째 기능: 환자의 문제 평가

- 망문문절(병력청취)만으로도 환자 상태의 60~80%를 확인할 수 있음

1) 비언어적인 경청 행동

- 환자에게 의사가 듣고 있다는 것을 느끼게 함
- 환자를 직접 바라보고, 주의 깊은 자세를 취함(열린 자세, 머리를 앞으로 숙이는 등)
- 책상 뒤로 물러나거나, 의자에 몸을 파묻고 있거나, 대화 중 커피를 마시거나, 진료 기록지를 쓰거나 읽는 것은 좋지 않음
✓ 진료기록지: 아예 안 쓸 순 X, 쓰면서 잘 듣고 있다는 표시만 해주면 됨

2) 질문의 형태

- 개방형(간접적) 질문: 어떤 주제/문제를 강조할지 환자에게 판단을 맡기는 것
ex. "어떻게 도와드릴까요?", "(갖고 있는) 두통에 대해 표현해주실 수 있나요?"
- 폐쇄형 질문: 한 단어로 대답할 수 있음
ex. "머리가 아프십니까?"
- 처음에 **개방형 질문** → 후에 점차 **폐쇄형 질문**으로 초점을 좁혀 들어감
> 환자가 자신의 불편함을 자유롭게 말하도록 한 후, 효과적인 진단 가설을 세우고, 점차 초점을 맞춘 질문을 통해 환자의 질병을 알아냄

3) 촉진 (facilitation)

- 환자가 개방형 방식으로 이야기를 계속하도록 **격려하는 면담자의 어떤 말/행동들**
ex. "두통에 대해서 더 자세히 말씀해보세요"
ex. 주의를 기울이며 고개를 끄덕이는 것, 주의 깊은 침묵, "아, 네~." "그렇군요.", 환자가 말한 마지막 몇 단어를 따라 하는 것 등
ex 환자: "두통이 알레르기가 심해지는 가을철에만 생기는 것 같아요"
의사: "가을철에만요?" → 더 자세히 말하도록 촉진해줌

4) 명료화와 지시

- 환자들이 전달하고자 하는 의미와 문제를 **조리 있는 이야기로 만들기 위해** 명료화 (clarification)하고 **유도적인 질문**을 해야 함. 내용이 산으로 가는 것을 방지
 - ① 불확실한 것을 명료화하고 방향을 잡기 위해 환자가 말하는 정보의 흐름을 중단시킬 수 있음
 - ② 문제를 발생순서대로 알기 위해 환자의 말에 참견할 필요가 있음
 - ③ 명료화 한 후, 다시 개방형 촉진을 계속 할 수 있음

5) 확인

- 언어는 오해되기 쉽고, 또한 의사가 **환자에 대한 잘못된 정보를 가지는 경우가 있음**
⇒ ∴ 전달된 정보의 **정확성을 확인하는 것은 필수적**
- 의사가 조사한 것을 확인하고 추가로 조사할 것을 알려주는 과정: 놓치는 것 없게

6) 문제들을 조사: "다른 문제들은 없는가?"

- "다른 불편한 문제는 없습니까?": 환자에게 가장 중요한 질문
- 가장 심각한 걱정을 말하는 것을 불안/부끄러워해 끝까지 주요 문제를 말하지 않을 수 있음: ex. 에이즈, 발기부전 / or 어떤 증상의 중요성을 모르기 때문일 수도 있음

7) 유도(편견이 섞인) 질문을 피하라

- 유도 질문: 어떤 대답을 유도하는 질문
- 환자는 의사에게 잘 보이기 위해 유도 질문에 **의사가 기대하는 대답을 하게 됨**
⇒ ∴ **편견을 최소화하는 질문하기**
ex. "제가 드린 약이 도움이 됐나요?"(X) → "상태가 어떠셨어요?"(O)

3. 세 번째 기능: 환자의 문제 치료(관리)

- 환자를 교육하고 치료에 잘 순응하도록 하는 것 (치료 과정을 얘기하는 것)
- 급성/생명에 위협을 주는 질병일수록, 처방에 따른 변화의 정도가 적을수록 환자가 더 잘 따름: 즉 가벼운 것일수록 순응도가 낮음 ex. 생활습관 지키는 것
- 교육, 동기부여, 강제치료(자주 사용X) 등을 통해 환자에게 영향을 줄 수 있음
- 기법 : ①질병교육 ②치료계획에 대한 협상과 유지 ③불순응 환자의 동기부여

1. 질병 교육 (6단계)

- 6단계: 생략하고 필요한 기법만 사용해도 됨, 전부 다 지킬 필요는 없음
- (1) 원인에 관한 환자의 생각을 알아내기
 - 환자가 갖고 있는 자신의 증상의 원인에 대한 두려움을 바로 언급하여 줄여줄 수 있음: ∵본인의 병이 심하다고 과장해 생각할 수 있으므로
- (2) 기초 진단을 알려주기 (짧고 간결하게)
- (3) 진단에 대한 환자의 감정에 반응하기
 - ex. “얼마나 놀라셨는지 알겠습니다.”: 이렇게 환자의 감정을 한 번 언급해주면 좋음
- (4) 질병에 대한 환자의 지식을 점검하기
- (5) 진단에 대해 자세히 설명하기
 - 환자가 이해할 수 있는 언어를 사용하고 요점을 분명히 하는 짧은 문장을 사용
- (6) 환자의 문제에 대한 이해를 점검하기 ex. 잘 이해하셨나요?

2. 치료계획의 협상과 유지 (7단계)

- (1) 기본 정보 확인하기
 - 환자가 치료에 대해 이미 알고 있거나 믿고 있는 것 확인
- (2) 치료 목표와 계획 말해주기
- (3) 이해도 점검하기
- (4) 환자의 선택과 치료 약속을 이끌어내기
 - 환자가 가능한 치료법들을 이해했다면, 환자에게 어떤 방법을 사용(선택)할지 물어봄
- (5) 계획을 협상하기: 생길 수 있는 문제와 그 해결책을 예측한다.
 - 환자가 바라는 것이 의사의 처방과 다를 수 있으므로, 치료계획을 세우는 데 환자와 협상이 필요: 즉 결국에는 환자의 니즈를 파악하는 것

- (6) 환자의 특정한 의도를 이끌어내기
- (7) 유지와 재발 방지 계획을 수립하기
 - 추적 방문 시 갈수록 순응도가 떨어지는 문제 주의 → 환자와의 약속을 끌어내기

3. 동기부여 (7단계)

- 환자가 치료계획에 순응하도록 동기를 유발하는 과정 역시 전부 다 지킬 필요 없음
- (1) 순응도를 주의깊게 관찰하기 (판단적이지 않게 개방형으로)
 - “약을 잘 드셨습니까?”보다 비판단적이고 더 개방적으로 질문
ex. “약 먹는 게 힘들진 않으셨어요?”
- (2) 특별한 순응도 문제 진단하기
 - 환자가 치료계획 유지의 어려움을 보이면 그 문제가 무엇인지 파악
 - ‘결심전(precontemplation)’ 단계: 치료 권유에 관심이 없거나 행동변화에 대해 생각하지 않는 단계
 - 변화를 고려하는 단계로 유도 ← 환자가 자신 행동이 건강에 미치는 결과를 확실히 이해하도록
ex. 운동 싫어하는 환자에게 “TV보는 동안 서있으세요.” (작은 변화부터)
- (3) 감정에 반응: 지지, 협력, 존중을 제공하기
 - 지지해주고, 동반자의식을 보여주며, 환자가 성공적으로 한 것은 존중하고 칭찬
- (4) 개인적 선호와 약속의 말을 이끌어내기
- (5) 해결책에 대해 협상하기
 - 환자들은 의사가 지시한 것보다 자신이 참여한 처방에 더 잘 따르기 때문
- (6) 의도(intent)와 재방문을 확인하기
- (7) 감정에 대해 계속적으로 반응하기
 - 대부분의 동기부여 노력은 불안, 슬픔, 분노, 부끄러움, 행복감 등을 불러일으킴. 이런 감정은 교육이나 동기부여 과정을 종종 방해하므로, 이를 알아차리면 의사-환자 관계 형성 기법으로 다시 돌아가 환자의 감정에 반응해야 함

5절. 비언어적인 의사소통

! 사람 사이의 메시지를 전달하거나 의사와 환자 사이의 상호작용의 흐름을 반영하는 모든 행동신호

1. 비언어적인 의사소통의 네 가지 범주

- ① 몸짓과 표정 ex. 얼굴표정, 몸짓, 접촉, 몸의 긴장도, 위치와 각도
- ② 인간 공간학 ex. 공간적인 관계와 장벽
- ③ 준 언어: 말투 ex. 리듬, 크기, 강약, 말의 속도
- ④ 자율신경계 반응 ex. 안면 홍조, 얼굴이 희어짐, 땀을 흘림 등

2. 환자의 기본적 행동

- 환자가 편안함을 못 느끼면 → 투쟁, 도피, 보존-퇴축과 같은 행위를 나타냄
- 어떤 하나의 신호에 집중하기보다, 전체적인 양식을 아는 것이 중요
- 1) 안정감: 이완, 물리적으로 열린 자세
- 2) 투쟁: 불안정을 느끼는 것에 대한 방어. 교전, 공격, 보복의 형태로 자주 나타남.
ex. 몸을 앞으로 기울임, 주먹을 꽉 쥐, 양 미간을 찌푸림
- 3) 도피: 물러남, 의자에 등을 기댈, 고개를 숙이고 돌림, 도망가고 싶은 반응
- 4) 소극적-퇴축: 과도한 정보에 압도당한다는 느낌이 들 때/충분한 보호반응이 불가능할 때 나타남 ex. 암 진단 소식(심각한 진단)을 들을 때 등
- 전형적으로 이탈, 부동성, 침묵 등 비언어적 유형을 나타냄

3. 비언어적인 기법

1) 비언어적인 라포를 형성하라

- 라포: '난 당신 곁에 있습니다'라는 의미, 공감의 비언어적 구조를 나타냄
 - (1) 맞추어주는 것(matching)
 - 환자가 하는 대로 움직여주는 것 ex. 목소리 큰 환자에겐 맞춰서 크게
But 너무 과장되지 않게
 - (2) 이끄는 것(leading)
 - 맞추어주는 것으로 형성된 상호 일치감을 이용하는 것
 - 상호 일치감이 존재하는지 알 수 있는 검사가 될 수 있음
ex. 의사가 천천히 말하면 환자도 천천히 말하게 되는 것

2) 공간 조절

- (1) 사람들 사이의 거리
 - 너무 가까우면 자신의 공간이 침입되었다고 느끼고, 너무 멀면 무관심한 느낌
- (2) 상하 높이의 차이 (누워있고, 앉아있고, 서있는 등)
 - 환자와 같은 높이 or 더 낮은 높이 ← ∴ 환자는 의사에 비해 약한 입장이라 생각
- (3) 물리적 장벽의 존재 (책상, 의자크기, 차트, 침대 손잡이 등)
 - 제거하거나, 적절하다면 그대로 두기
- (4) 서로 바라보는 각도 (정면으로 마주보기, 어깨와 어깨를 나란히, 또는 그 사이의 각도)
 - 마주보면 맞선다는 느낌이 들 수 있음 ⇒ ∴ 나란히 or 대각선

3) 혼란스러운 표현을 정리하기

- 환자의 언어적 표현 - 비언어적 표현이 일치하지 않는다면, 비언어적 표현이 환자의 실제 느낌을 더 반영함 ex. 약 먹으라고 했는데 환자가 팔짱끼고 "네~"하는 것

4. 세 가지 기능적 접근을 적용하기

1) 관계 형성하기

- 면담 시작 전: 면담 공간의 구성에 신경 쓰기
- 면담 시작 후: 맞추어주기(matching) 시작

2) 환자의 문제들을 평가하기

- '나는 관심이 있다'는 것을 표현 → 환자들이 모든 정보를 자연스럽게 제공하도록
- 질문에 빚나가는 대답을 한다면, 환자와 라포를 유지하면서 이끄는 것(leading) 등을 사용하여 끊는다는 느낌 없이 방향을 바꾸기 (=땀 데로 땀을 때, 자연스럽게 돌아오기)

3) 환자의 문제들을 다루기

- 비언어적인 라포 속에 있어야 환자들이 진단/처방을 더 잘 받아들임